★★☆腹外疝（0~3题）

- 分类
  - 易复疝 —— 小肠最常见
  - 难复疝“粘住了”（2015）
    - 大网膜最常见“小的难忘”
    - 滑疝（2022、2024）—— 疝内容物成为疝囊一部分（切疝囊时避免误伤疝内容物，2022）
疝内容物以盲肠、阑尾、乙状结肠、膀胱多见（右侧多见）
常有消化不良、便秘
  - 嵌顿疝“卡住了”（疼痛明显、可肠梗阻）
    - Richter 疝 / 肠管壁疝“人民币” —— 嵌顿内容物仅为部分肠管壁
易误诊（局部肿块不明显、多无肠梗阻）
    - Littre 疝 —— 嵌顿内容物为小肠憩室如 Meckel 憩室
    - Maydl/ 逆行性嵌顿疝（2014、2026）—— 嵌顿肠管包括几个肠袢、呈 W 形
即使疝囊肠管存活仍须将腹腔肠袢牵出检查以免遗漏坏死肠袢
    - Amyand 疝 —— 嵌顿内容物为阑尾“appendix”
  - 绞窄疝（血运障碍）
  - 切口疝 —— 经腹直肌切口最常见，切口感染是最常见原因（2015、2026）
- 治疗
  - 保守 —— ＜1岁、＜2岁脐疝、不耐受手术“小脐没必要”
  - 单纯疝囊高位结扎（2007、2019、2026）—— ＞1岁婴幼儿、绞窄疝（并切除坏死肠管）“结扎大一窄”
  - 单纯疝修补 / 无张力疝修补如 Rutkow、Stoppa、Lichtenstein 法“亚狮龙”（2008、2022、2026）—— ①疼痛轻、恢复快、低复发、最常用
②但材料作为异物可引起感染
  - 疝囊高位结扎 + 修补（2009）
    - Ferguson 法：加强前壁“Front”
    - Bassini 法：最常用“BBB 话最多”
    - McVay 法：股疝、严重薄弱者，把腹内斜肌和联合腱缝合至耻骨梳韧带“摸屁股严重可耻”
    - Shouldice 法：成人的大斜疝和直疝“应该大鞋子”，重点修补腹横筋膜和内环“横 S 征”
    - Halsted 法